Auszug aus „Unterricht Pflege" Precios-Verlag 5/2004

soll hier die äußerst schädigende Wirkung des pflegerischen Handelns auf die Person mit Demenz verdeutlichen. Das maligne Setting kann sich nicht nur auf das Personsein äußerst schädigend auswirken, sondern auch das körperliche Wohlbefinden der Person untergraben (Kitwood 2004, S. 75). Kitwood verwies explizit darauf, dass das Untergraben des Personseins nicht bewusst und in böswilliger Absicht geschieht. Er sah die Malignität und die damit verbundene „personale Detraktion" (z.B. entmächtigen, lächerlich machen, Infantilisieren) als Teil unseres kulturellen Erbes, welches abweichendes Verhalten ächtet und sanktioniert. Maligne Sozialpsychologie zeigt sich in unserer Gesellschaft tagtäglich in vielen Beziehungen und Interaktionen, es kann insbesondere bei der Kindererziehung beobachtet werden (Kitwood 2004, S. 75).

3.5.2 Die benigne Sozialpsychologie

Die benigne (gutartige) Sozialpsychologie oder die positive Arbeit an der Person führt, wenn sie gelingt, in vielen Fällen zu einer Aufrechterhaltung und Stärkung des Personseins - und somit zu einem relativen Wohlbefinden des Menschen mit Demenz. Kitwood ging davon aus, dass eine Person ohne die Befriedigung ihrer menschlichen Bedürfnisse nicht funktionieren kann. Dies setzt voraus, dass die Bedürfnisse der jeweiligen Person von den Pflegenden erkannt und dass diesen Bedürfnissen verlässlich nachgegangen wird. Die Bedürfnisse von Menschen mit Demenz unterscheiden sich nicht wesentlich von denen eines Menschen ohne Demenz. Ein wesentlicher Unterschied besteht jedoch darin, dass Menschen mit Demenz ihre Bedürfnisse häufig nicht so direkt äußern können und somit davon abhängig sind, dass Pflegende sensibel im Aufspüren der jeweiligen Bedürfnisse sind. Zentrale psychische Bedürfnisse verbergen sich häufig hinter sogenannten „problematischen Verhaltensweisen" (z.B. schreien, kratzen, hinterherlaufen). Pflegende sollten dieses Verhalten als Kommunikationsversuch des Menschen mit Demenz deuten. Es sollte sie „herausfordern", die Intention, die hinter diesem Verhalten liegt, herauszufinden und ihr zum Gelingen zu verhelfen (Müller-Hergl 2000). Diesem Gedankengang liegt die Annahme zu Grunde, dass jedes Verhalten eines Menschen mit Demenz einen Sinn hat – auch wenn er nicht immer erkennbar ist. Kitwood hat fünf zentrale psychische Bedürfnisse identifiziert, die sich gegenseitig überlappen und sich in dem zentralen Bedürfnis nach großzügiger, bedingungsloser, verzeihender Annahme - nach Liebe - verbinden. (Kitwood 2004, S.121) Diese Bedürfnisse sind Trost, primäre Bindung, Einbeziehung, Beschäftigung und Identität.

3.5.2.1 Trost

Trost wird insbesondere Menschen gespendet, die sich in einer hoffnungslosen, verzweifelten Situation befinden. Menschen mit Demenz Trost zu spenden bedeutet, die Situation, in der sie sich befinden, empathisch wahrzunehmen und ihr Leiden anzuerkennen. Demenz ist für die betroffenen Personen mit vielfältigen Verlusten verbunden. Verlust an sozialen Beziehungen, Verlust von Fähigkeiten, Verlust der Kontrolle, Verlust eines unabhängigen Lebensstils - somit ist ihr dringliches Verlangen nach Trost nur allzu verständlich.

Einem Menschen mit Demenz Trost zu spenden bedeutet, ihm in seiner Not ganz nahe zu sein, ihm Stärke, Verlässlichkeit, Sicherheit und Geborgenheit zu vermitteln (Kitwood 2004, S. 123). Menschen kennen intuitiv und kulturübergreifend vielfältige Arten, sich auf körpersprachlicher Ebene Trost zu spenden: ein verständnisvolles Nicken, das Halten einer Hand, das Reichen eines Taschentuches oder das Abwischen von Tränen, eine zärtliche, umfassende Umarmung, ein gemeinsames rhythmisches Hin- und Herwiegen oder das Streicheln über den Rücken. Körpersprachliche Gesten wie diese, die man im Alltag beobachten kann, vermitteln Gefühle mit hoher Authentizität.

3.5.2.2 Primäre Bindung

Primäre Bindungen sind für alle Menschen, unabhängig von der Altersstufe, elementar. Ein Mensch, der in kurzer Zeit mehrere Bindungen verliert, ist davon bedroht, sich zu verlieren (Kitwood 2004, S. 123). Das Verlangen nach Bindung beinhaltet den Wunsch nach Verlässlichkeit, Sicherheit und Schutz. John Bowlby (1975) hat innerhalb seiner Bindungstheorie zahlreiche Belege dafür geliefert, dass das Phänomen der sozialen Bindung bedeutsam für die Entwicklung des Kleinkindes ist. Ferner konnte im Rahmen der Attachment-Forschung nachgewiesen werden, dass das Kleinkind in Belastungssituationen, in denen es sich unwohl fühlt, *eine* bekannte Bindungsperson (in der Regel die Mutter) deutlich vor anderen Personen bevorzugt. In anderen Situationen, z. B. wenn das Kind spielen möchte, herrscht nicht das „Bindungsverhaltenssystem" sondern das „Erkundungssystem" vor und es werden auch andere Personen akzeptiert (Trautner 1992, S.53).

Menschen mit Demenz sind vielfältigen Stress- und Belastungssituationen ausgeliefert, sie verstehen ihre innere und die sie umgebene äußere Welt häufig nicht mehr. Es ist anzunehmen, dass durch dieses „Nicht verstehen" das Verlangen nach Sicherheit, nach primärer Bindung, in ähnlicher Intensität hervortritt wie bei Kindern (Kitwood 200, 123). Dieses Verlangen drückt sich auch deutlich in dem sogenannten Attachment-Verhalten (Anklammern, Hinterherlaufen) aus. Mit Fortschreiten des demenziellen Prozesses sind Menschen mit Demenz immer weniger in der Lage, von sich aus Beziehungen zu gestalten. Sie benötigenden dazu die Hilfe anderer, beziehungsfähiger Menschen. Bère Miesen brachte das Konzept von Attachment als erster in die Demenzdiskussion mit ein (vgl. hierzu Miesen 1999).

3.5.2.3 Einbeziehung

Das soziale Leben von Menschen findet in Gruppen statt. Entwicklungsgeschichtlich betrachtet war die Gruppe für den Menschen lebensnotwendig, er konnte nur als Teil einer funktionierenden Gruppe überleben. Das Verlangen, Teil einer Gruppe zu sein, dazuzugehören und gesellschaftliches Miteinander zu erleben, ist bei Menschen mit Demenz vorhanden. Die Art und Weise der Beteiligung ist, wie bei allen Menschen, individuell unterschiedlich. Menschen mit Demenz können sich mit Fortschreiten des demenziellen Prozesses immer weniger selbst in eine Gruppe einbringen, sie benötigen dazu die verbindende, feinfühlige Unterstützung anderer Menschen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass sie sich innerhalb der Gruppe überfordert, ausgegrenzt und unwohl fühlen. Jeder hat schon mal erfahren, dass es durchaus möglich ist, äußerlich Teil einer Gruppe zu sein und sich trotzdem innerhalb dieser Gruppe zutiefst einsam und „fehl am Platze" zu fühlen. Diese Phänomen, „allein in einer Gruppe zu sein", kann man oft im Heimalltag beobachten: Men-

schen (die sich nicht kennen) sitzen gemeinsam in einem Raum und dennoch gibt es nichts, kein „Thema", was sie verbindet. Es gibt keine Person, die sich um den Gruppenprozess, der ja durchaus stattfindet, kümmert. Solche unklaren Situationen sind selbst für Menschen, die die Situation kognitiv erfassen können, schwer auszuhalten. Auf Menschen mit Demenz wirken diese Situationen oft bedrohlich und rufen unterschiedliche Gefühle und Verhaltensweisen hervor. So nimmt nicht selten eine Gruppendynamik ihren Lauf, die aufreibend, verletzend und schädigend für die beteiligten Personen ist. Gruppenangebote sollten begleitet und spezifisch an die Lebensgeschichte, Interessen und Fähigkeiten der teilnehmenden Menschen angebunden sein. Nur so kann Gruppenzugehörigkeit eine persönlichkeitserweiternde Funktion habe.

3.5.2.4 Beschäftigung

Das Verlangen, beschäftigt zu sein, entspringt aus dem Anrieb, etwas bewirken zu wollen, die Wirkung des eigenen Handelns zu spüren und sich so selbst in seinem Sein zu erfahren. Das Gegenteil von beschäftigt sein ist Langeweile, Apathie und Bedeutungslosigkeit (Kitwood 2004, S. 124). Beschäftigt zu sein kann viele Facetten annehmen: Man kann alleine oder mit anderen zusammen beschäftigt sein, man kann bei der Arbeit oder in der Freizeit beschäftigt sein. Beschäftigt zu sein hat einen großen Einfluss auf Wohlbefinden und Selbstwertgefühl des Menschen. Arbeit beispielsweise besitzt psychosoziale Funktionen wie Aktivität und Kompetenz, Zielstrukturierung, Kooperation und Kontakt, soziale Anerkennung und persönliche Identität (Padlinar 2000). Menschen, die ihre Beschäftigung verlieren und von Arbeitslosigkeit betroffen sind, fühlen sich häufig hilflos, verzweifelt, minderwertig und schämen sich für ihre Situation. Diese Situation mündet nicht selten in sozialen Rückzug und Einsamkeit (Padlinar 2000).

Auch Menschen mit Demenz haben das Bedürfnis, sich zu beschäftigen. Dieses lässt sich häufig daran beobachten, dass sie anderen helfen möchten. Für Pflegende ist es oftmals nicht leicht, diesem Bedürfnis adäquat nachzukommen. Damit das Bedürfnis nach Beschäftigung wirklich befriedigt werden kann, ist es zum einen wichtig, mit dem Menschen gemeinsam die für ihn richtige Art der Beschäftigung zu finden. Diese kann, muss aber nicht zwangsläufig, an lebensgeschichtlich geprägte Aufgaben und Aktivitäten anknüpfen. Zum anderen gilt es, den richtigen Grad der Unterstützung zu finden, um so dem Menschen, ohne ihn zu über- oder zu unterfordern, zu einem Gefühl der Zufriedenheit zu verhelfen (Kitwood 2004, S. 124).

3.5.2.5 Identität

Identität bedeutet zu wissen, wer man ist, sowohl im Erkennen als auch im Fühlen. Identität zu haben bedeutet somit, dass ich über mich selbst eine Geschichte erzählen kann: Wo komme ich her? Wo bin ich? Wohin gehe ich? Der Prozess der Identitätsfindung geschieht nach Erikson immer in Wechselseitigkeit mit der sozialen Umwelt und erstreckt sich über die gesamte Lebensspanne. Erikson verstand unter Identität „die im Laufe der Entwicklung wachsende Fähigkeit, sich trotz ständiger Veränderungen sowohl in Übereinstimmung mit seinem früheren Selbst zu erleben (selfsamenes = Bewusstsein der Kontinuität) als auch in Übereinstimmung mit dem Bild, das sich die anderen von einem machen." (Trautner 1992, S. 81). Menschen mit Demenz geht dieses Bewusstsein der Kontinuität zusehens verloren. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Identitätsgefühl zwangsläufig verloren gehen muss, denn Identität zu haben ist nicht vollständig an Kognition gebunden, sondern auch von Erleben und Fühlen abhängig (Bradford Dementia Group 1997, S. 10). Um das Bedürfnis nach Identität ausreichend befriedigen zu können, benötigen Menschen mit Demenz die Unterstützung des sozialen Umfeldes. Pflegende können durch Identitätserhaltende Maßnahmen, z.B. durch Biographiearbeit und Erinnerungspflege, dazu beitragen, die Identität von Menschen mit Demenz bis zu einem bewissen Grad zu bewahren (vgl. hierzu Trilling et al 2001). Ferner ermöglicht die Fähigkeit zur Empathie, so auf eine Person zu reagieren, wie es ihrer Einzigartigkeit, ihrer Individualität entspricht.

Kitwood war davon überzeugt, dass durch sensibles Befriedigen der hier vorgestellten Gruppe von Bedürfnissen das Personsein des Menschen mit Demenz erhalten bleiben kann. Er ging davon aus, das die Befriedigung eines Hauptbedürfnisses sich auf die andere Bedürfnisse positiv auswirkt.

Die positive Arbeit an der Person geschieht in der Interaktion mit dem betroffenen Menschen. Interaktion wird hier nicht im Sinne des Behaviorismus (Reiz-Reaktion) sondern im Sinne des Symbolischen Interaktionismus verstanden. Hierbei geht es um die Herstellung von Bedeutungen und um die Gemeinsamkeit von Bedeutungen zwischen mehreren handelnden Personen. Ich reagiere nicht nur auf die Signale, die eine Person aussendet, sondern ich reagiere auf die Bedeutungen, die mir von der Person übermittelt werden. Interaktion beinhaltet nach Kitwood Reflexion, Antizipation, Erwartung und Kreativität (2004, S. 131).
Kitwood hat verschiedene Arten positiver Interaktion identifiziert, die jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit haben (vgl. Tabelle auf der nächsten Seite).

4. Die Bedeutung des person-zentrierten Ansatzes für die Gestaltung von Lernsituationen

Der person-zentrierte Ansatz eignet sich dazu, „pflegerisches Denken und Handeln zu leiten" (Riesner 2004, S. 11). Aus der Perspektive der Pflegewissenschaft wird der zu pflegende Mensch, sein subjektives Erleben und seine individuelle Lebens- und Alltagsgestaltung, zunehmend mehr in das Zentrum des Forschungsinteresses gerückt (Moers et al 1999). Ob in der Pflegepraxis diesbezüglich ebenfalls ein Perspektivwechsel zu verzeichnen ist, kann an dieser Stelle nicht hinreichend geklärt werden. Verschiedene Veröffentlichungen weisen jedoch darauf hin, dass in Deutschland stärker krankheits-, symptom- und verrichtungsorientiert und somit weniger personzentriert gepflegt wird (Beyer 2001, Petry 1996, Schopp et al. 2001). Für die Unterrichtspraxis lässt sich ähnliches vermuten, wenngleich dieses bisher auch noch nicht hinreichend untersucht worden ist. Im Rahmen von Unterrichtsbesuchen kann man jedoch immer wieder beobachten, dass die jeweilige Erkrankung und nicht der zu pflegende Mensch im Vordergrund der Betrachtung steht. Weiterhin fällt auf, dass Pflege auf Handlungsabläufe reduziert wird, in denen der zu pflegende Mensch nicht einmal vorkommt. Hierdurch wird bei den Lernenden, wenn auch nicht bewusst, eine krank-